



PROTOCOLO DE REEVALUACIÓN PERIODONTAL

Clínica Universitaria de Odontología

1. OBJETIVO:

Determinar la respuesta del paciente al tratamiento:

- Valorar la **respuesta clínica** al tratamiento.
- Comprobar la **mejora en la inflamación y profundidad de bolsas**
- Verificar el **control de placa** y compromiso del paciente.
- Tomar decisiones sobre la necesidad de:
 - Mantenimiento periodontal.
 - Terapia quirúrgica adicional.
 - Reeducación en higiene oral.

2. CUANDO REALIZARLO:

Se realiza a las **4-6 semanas** después de haber finalizado el tratamiento periodontal no quirúrgico -raspado y alisado radicular- (RAR).

3. PROTOCOLO:

A. Revisión médica y hábitos

- Confirmar cambios en salud general, medicamentos o hábitos (tabaco, dieta- recordar la importancia de mantener unos buenos controles de glucemia en los pacientes diabéticos-, etc.).

B. Evaluación de higiene oral

- Índice de placa y sangrado.
- Revisión de técnica de cepillado y uso de complementos (hilo, interproximales).
- Reforzar y corregir según necesidad.

C. Sondaje periodontal

- De igual forma que el sondaje inicial.
- Comparar profundidad de sondaje con registros previos.
- Evaluar sangrado al sondaje y supuración.
- Revalorar movilidad dentaria y furcaciones.

D. Evaluación de tejidos blandos

- Cambios en color, consistencia, textura y presencia de recesiones gingivales.

4. CRITERIOS DE ÉXITO

- Reducción de bolsas periodontales ≥ 1 mm.
- Disminución significativa del sangrado al sondaje (<20%).
- Índice de placa controlado (<20% ideal).
- Tejidos gingivales firmes, sin inflamación ni supuración.

5. CRITERIOS DE FRACASO O ÉXITO PARCIAL

- Persistencia de bolsas profundas (>5 mm con sangrado).
- Inflamación persistente a pesar del control de placa.
- Paciente no cumple con la higiene oral.
- Posible necesidad de tratamiento quirúrgico periodontal.

6. INSTRUMENTAL NECESARIO

- Kit exploración con espejo y sonda periodontal

